EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 94088
SERVICIO : MEL MUJERES HSC
FECHA : 2024-10-03 12:33:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: JUAN RAFAEL MUNOZ GUZMAN			RUN	: 5.683.537-7
F.Nac	: 25-01-1947	Edad	: 77 AÑOS, 8 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: LLAHUIMAVIDA			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 99123198 52151512		
Fecha Ingreso	: 2024-09-23	Fecha Egreso	: 2024-10-03 12:33:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I21.9-INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

Insuficiencia respiratoria aguda
-Neumonia basal derecha
-Derrame pleural derecho leve
Obs CA páncreas
-Dilatación de conducto pancreático principal | Atrofia parénquima pancréatico distal
-Carcinomatosis peritoneal secundaria
Trombosis vena esplénica | HAS BLED
¿IAM TIPO 2?
DM2 NIR
Ca prostatico en CP

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J96.0-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente hospitalizado inicialmente en contexto de insuficiencia respiratoria aguda asociada a proceso neumónico de base con compromiso general. Para momento de ingreso, con elevación de parámetros inflamatorios, con requerimiento de oxígeno, con clínica respiratoria de al menos dos días de evolución.
Durante estancia se inicia con terapia ATB con ceftriaxona cumpliendo al menos 10 días. Se intenta tomar CSB sin secreciones adecuadas para ello.
Con requerimiento de oxígeno hasta MAF, descendiendo progresivamente buscando destete hasta alcanzar saturación límite 88-90% con 1.5Lt por NRC para el día de hoy.
Desde el punto de vista infeccioso controles paraclínicos destaca PCR actual en 161.
Función renal con leve compromiso durante estancia: Crea tope 1.7 sobre crea basal 1. Actual de egreso 1.3, en regresión.
Se tomó TC TAP en contexto de proceso infeccioso severo el cuál reportó nueva lesión pancreática sugerente de Neo, con carcinomatosis peritoneal.
Persiste con requerimiento de oxígeno a pesar de apoyo ventilatorio y terapia con KNT. En vista de ello se considera derivar a HODOM para continuidad de atención.

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo Semisentado 30°
2. Regimen Liviano Hiposodico A Tolerancia
3. O2 para sat >90%

4. Bromuro De Ipratropio 4 Puff C/6hrs Por Ac
5. Brexotide 2 puff c12h
6. Knt Motora Y Resp diario
7. Metadona 1/4 Am 1/2 Pm
8. Bicalutamida 50 1 Dia Vo
9. Aerogastrol 1 Dia
10. Piascledine 1 Dia
11. Omeprazol 20mg vo dia
12. Paracetamol 1gr vo c8h SOS
13. AAS 100mg vo dia
14. Atorvastatina 80mg vo dia
15. Pregabalina 75mg vo dia
16. Tamsulona 0.4mg vo dia
17. Levotiroxina 100mcg vo dia
18. Domperidona 10 gotas c24h
19. Control SU SOS
20. LET IIIc NO IOT NO RCP

EXÁMENES Y RESULTADOS

01/10 Crea 1.3, Lactato 1.3, PCR 171, BUN 26, Uremia 55, Hb 12.4, Procalcitonina 0.
25/09 UCT negativo
24/09 PCR 25, Crea 1.4, Calcio 8.4, Uremia 52, ELP 137/3.8/108 Hb 11.7.
TAC de torax s/c -> Atelectasias subsegmentarias con componente condensante en la base derecha.
Derrame pleural derecho.
Cardiomegalia derecha y signos de hipertensión pulmonar. Ateromatosis aortocoronaria.
Ascitis y alteración omental no caracterizable en este estudio. No es posible descartar compromis

TC TAP 30/09
Lesión hipovascular en cuerpo de pancreas aspecto sospechoso para un origen neoplásico, determina dilatación del conducto pancreático principal y atrofia del parénquima pancreático hacia distal. Se recomienda complementar con RM. Trombosis de vena esplenica posiblemente por compromiso infiltrativo. Egrnosamiento peritoneal de predominio derecho y acentuada ascitis, posiblemente ne contexto de carcinomatosis peritoneal secundaria. Foco de condensación basal derecha, de posible origen infeccioso.

andres david velasquez guerra
MEDICO TRATANTE
27124399-5

JEFE SERVICIO